

Цитомегаловирусная инфекция

Мамбетова С.Т.

г.Аытрау

Цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВ) можно эффективно лечить. Существуют три группы пациентов, для которых актуален контроль за активностью ЦМВ. Это беременные; лица, страдающие рецидивирующим герпесом; пациенты с нарушенным иммунным ответом.

1. Цитомегаловирус и беременность. Эта проблема беспокоит каждую четвертую женщину детородного возраста. Им необходимо:

- подготовка к беременности женщин, страдающих герпесом и ЦМВ-инфекцией;
- своевременные лечебно-профилактические мероприятия во время беременности и при подготовке к родам - это реальная возможность избежать негативного влияния цитомегаловируса на течение беременности, развития патологии плода и новорожденного.

2. Цитомегаловирус и генитальный герпес - одна из причин плохо поддающегося терапии рецидивирующего герпеса при любой локализации процесса; смешанная ЦМВ-ВПГ- инфекция, что требует значительной коррекции в проводимом противорецидивном лечении.

3 Цитомегаловирус и иммунитет:

- у лиц с нормальным иммунитетом (иммунокомпетентных) цитомегаловирус обычно находится в латентном (спящем) состоянии, не причиняя человеку вреда. При активации латентной инфекции могут возникать рецидивирующие бронхиты, пневмонии, воспаление периферических лимфатических узлов (лимфоаденопатия), астения: субфебрильная температура тела, ознобы, повышенная утомляемость, недомогание.

- у лиц с иммунодефицитом (ВИЧ-инфицированные, химиотерапия по поводу злокачественных новообразований, иммуносупрессивная терапия при трансплантации внутренних органов) цитомегаловирус вызывает тяжелые заболевания (поражение глаз, легких, пищеварительной системы и головного мозга), которые могут приводить к смерти.

Распространенность и пути заражения ЦМВ

Цитомегаловирус был открыт в 1956 г. Возбудитель (Cytomegalovirus hominis - ЦМВ) относится к семейству герпес вирусов (herpesviridae). Вирус имеет сродство к ткани слюнных желез и при локализованных формах обнаруживается только в этих железах. ЦМВ персистирует в организме (сохраняется) пожизненно. Он широко распространен в популяции. Антитела к цитомегаловирусу выявляют у 10-15% подростков. К возрасту 35 лет эти антитела выявляют уже у 40% людей.

ЦМВ не очень заразен. Для заражения обычно требуются длительное, тесное общение или многократные контакты.

Заражение цитомегаловирусом происходит:

- в быту: воздушно-капельным путем и контактным со слюной при поцелуях;
- половым путем: контактным - со спермой, слизью шейки матки;
- при переливании крови и трансплантации донорских органов;

- трансплацентарный путь - внутриутробное инфицирование плода;
- инфицирование ребенка в послеродовом периоде через грудное молоко больной матери.

Клинические проявления цитомегаловирусной инфекции

Длительность инкубационного периода составляет от 20 до 60 дней. Острая фаза болезни длится от 2 до 6 недель: повышение температуры тела и появление признаков общей интоксикации, ознобы, слабость, головная боль, боли в мышцах явления бронхита.

В ответ на первичное внедрение развивается иммунная перестройка организма. После острой фазы в течение многих недель сохраняется астенизация, иногда вегетативно-сосудистые расстройства. Множественное поражение внутренних органов.

Наиболее часто ЦМВ-инфекция проявляется как ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). В этом случае больные жалуются на слабость, общее недомогание, быструю утомляемость, головные боли, насморк, воспаление и увеличение слюнных желез, с обильным отделением слюны и белесоватыми налетами на деснах и языке.

Генерализованная форма ЦМВ-инфекции с поражением внутренних (паренхиматозных) органов. Наблюдается воспаление печеночной ткани, надпочечников, селезенки, поджелудочной железы, почек. Это сопровождается частыми «беспричинными» пневмониями, бронхитами, плохо поддающимися антибиотикотерапии; отмечается снижение иммунного статуса, уменьшается количество тромбоцитов в периферической крови. Нередки поражение сосудов глаза, стенок кишечника, головного мозга и периферических нервов. Увеличение околоушных и подчелюстных слюнных желез, воспаление суставов, кожная сыпь.

Поражение органов мочеполовой системы у мужчин и женщин проявляется симптомами хронического неспецифического воспаления. Если не установлена вирусная природа имеющейся патологии - заболевания плохо поддаются антибиотикотерапии.

Патология беременности, плода и новорожденного - наиболее серьезные осложнения ЦМВ-инфекции.

Максимальный риск развития этой патологии возникает при инфицировании плода во время беременности. Однако, необходимо помнить, что проблемы нередко возникают и у беременных с активацией латентной ЦМВ-инфекции с развитием вирусемии (выход вируса в кровь) с последующим заражением плода. ЦМВ - одна из наиболее частых причин невынашивания беременности. Внутриутробная ЦМВ-инфекция плода приводит к развитию тяжелых заболеваний и поражений центральной нервной системы (отставание в умственном развитии, тугоухость). В 20-30 % случаев ребенок погибает.

Диагностика герпесвирусных (ВПГ и ЦМВ) инфекций

- Диагноз ВПГ и ЦМВ-инфекции можно ставить (особенно при малосимптомной, атипичной и скрытой формах герпеса) только на основании выявления вируса в

биологических жидкостях организма (кровь, моча, слюна, отделяемое половых путей) методом ПЦ1 или при специальном посеве на культуру клеток;

- ПЦР отвечает на вопрос: вирус обнаружен или нет, но не дает ответа об активности вируса;

- посев на культуре клеток не только выявляет вирус, но и дает информацию о его активности (агрессивности). Анализ результатов посева на фоне лечения позволяет делать заключение об эффективности проводимой терапии;

- антитела IgM могут свидетельствовать или о первичной инфекции или об обострении хронической инфекции. Антитела IgG говорят только о том, что человек с вирусом

встречался, инфицирование произошло. IgG при герпес-вирусных инфекциях сохраняется пожизненно (в отличие, например, от хламидиоза). Есть инструкции, в которых IgG имеют диагностическое значение.

Лечение ЦМВ-инфекции должно быть комплексным, включать в себя иммунную и противовирусную терапию. ЦМВ довольно быстро уходит с периферии и перестает выделяться из биологических жидкостей (кровь, слюна, грудное молоко) - наступает латентная фаза инфекции. Качественно проведенная иммунотерапия активизирует защитные механизмы, которые контролирует в дальнейшем активацию латентной ЦМВ инфекции.